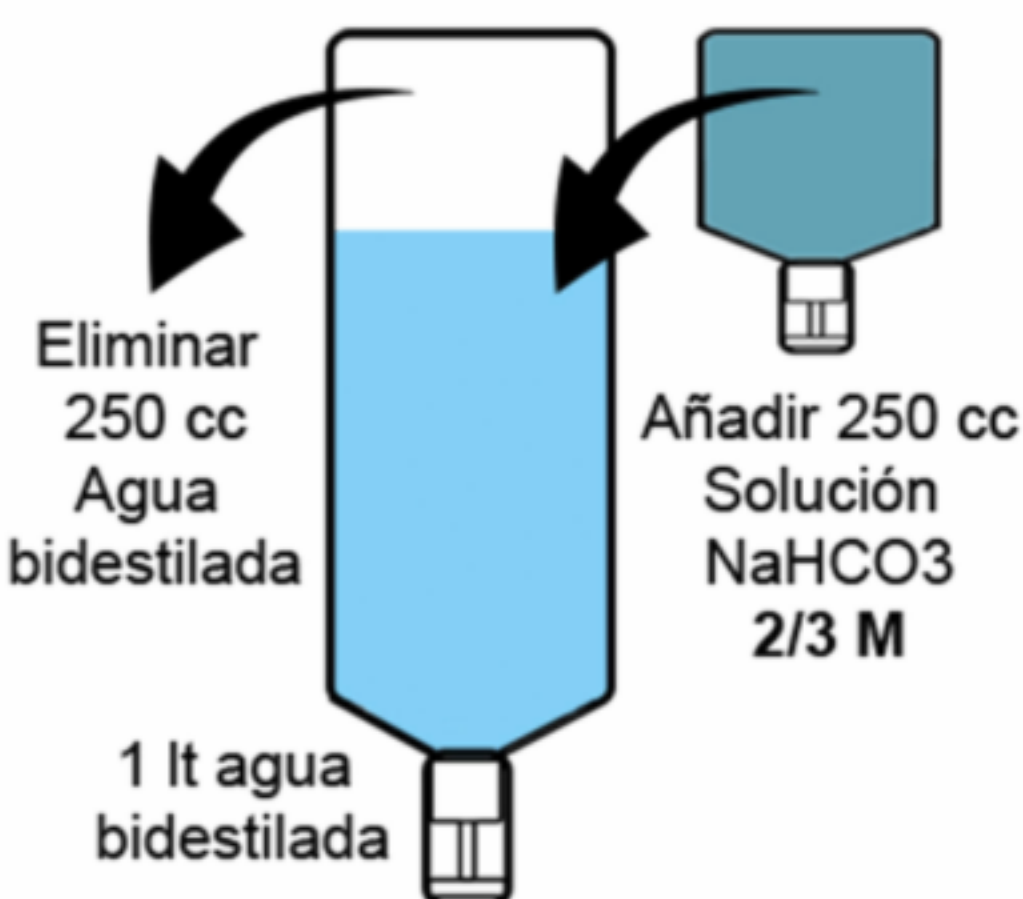




Infusión de Bicarbonato

Vía periférica:



1 Lt de Solución **1/6 M**

Osm: 333 mosm/lit (similar a SF0,9%)

HCO₃: 166,7 meq/lit (0,16 meq/ml)

Na: 166,7 meq/lit

Vía central (CVC):



1 Lt de Solución **2/3 M**

Osm: 1333 mosm/lit

HCO₃: 666,7 meq/lit (0,66 meq/ml)

Na: 666,7 meq/lit

Considerar HCO₃ en: PH: < 7,1 con HCO₃ <6-10.

(sobre todo si acidosis metabólica hiperclorémica aguda)

- Calcular déficit de HCO₃ (solo usar como estimación). **Objetivo: PH 7,2**

- 50% del déficit en 4 hrs (< 1-2 meq/kg), resto en 24-48 hrs

- En Paro cardiorespiratorio: 1 meq/kg y recontrolar.

- 1/6 M: administración sin restricción. Ojo con sobrecarga de volumen

- 2/3 M: velocidad según natremia (no más de 0,5 meq/lit/hr de ascenso de Na)

- Monitorizar: PH, PaCO₂, Na, K, Ca iónico.

Cetoacidosis (si PH < 6,9)

150 ml HCO₃ 2/3 M ó 100 ml HCO₃ 8,4%

Diluir en: 400 ml bidestilada

Agregar: 20 meq de K (si K < 5,3 meq/lit)

(2 amp KCL=26 meq / 2 amp monofosfato de K: 22 meq)

Infundir en: 2 hrs Repetir si persiste PH < 6,9

